

Relatório Médico Complementar

A/C: Dr LUCAS SANTOS SAMPAIO DE SOUSA

Ref.: Tratamento com Extrato de Óleo de Cannabis spp.

Prezado(a) Dr **LUCAS SANTOS SAMPAIO DE SOUSA**,

Segue, conforme solicitado, o relatório médico com explicação detalhada das necessidades clínicas do paciente Carlos Vinicius Rocha Reis, bem como as diferenças entre o tratamento atual e as alternativas fornecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

1. Necessidades Terapêuticas do Paciente O paciente apresenta as seguintes condições clínicas:

- Ansiedade generalizada;
- Glaucoma;
- Asma brônquica;
- Distúrbios do sono.

Essas condições, em conjunto, comprometem significativamente a qualidade de vida do paciente, causando limitações em atividades diárias e aumento de riscos à saúde, como crises asmáticas graves e agravamento do glaucoma.

Desde 2013, o paciente realiza tratamento com extratos de óleo de cannabis ricos em **7.500 mg de CBD** e **4.500 mg de THC** trimestralmente, proporções que demonstraram efetividade comprovada para controle de seus sintomas e retorno às atividades pessoais e laborativas necessárias à sua subsistência. Antes da adoção deste tratamento e um longo período de adaptação e ajustes de doses até as atuais, as abordagens convencionais não resultaram em resposta terapêutica satisfatória.

2. Diferenças Entre o Tratamento Necessário e as Alternativas do SUS A seguir, destaco as principais limitações das opções disponíveis pelo SUS em comparação às necessidades específicas do paciente:

2.1. Concentrações de Princípios Ativos O SUS fornece medicamentos com CBD isolado ou THC em concentrações muito baixas, indicados principalmente para epilepsia refratária ou esclerose múltipla. Essas formulações não atendem à dosagem de 7.500 mg de CBD e

4.500 mg de THC necessárias para o paciente. Sem essas proporções, os sintomas do paciente não são controlados adequadamente.

2.2. Indicações Clínicas Reconhecidas As condições do paciente, como ansiedade generalizada e glaucoma, não estão entre as patologias para as quais o SUS reconhece e distribui medicamentos baseados em cannabis. Essa restrição impede que o paciente tenha acesso ao tratamento adequado por meio do sistema público.

2.3. Personalização do Tratamento O tratamento do paciente exige personalização, com formulações adaptadas às suas necessidades específicas. O SUS não oferece essa flexibilização, o que inviabiliza o controle eficaz das patologias.

3. Riscos da Interrupção ou Substituição do Tratamento A descontinuidade ou substituição do tratamento com o óleo de cannabis representa sérios riscos à saúde do paciente, incluindo:

- **Agravamento da ansiedade:** Recidiva dos sintomas pode levar a crises mais severas e desestabilização emocional.
- **Progressão do glaucoma:** Sem controle adequado, o glaucoma pode progredir para perda irreversível da visão.
- **Aumento das crises asmáticas:** A falta de controle adequado pode colocar o paciente em risco de vida.
- **Impacto no sono e na qualidade de vida:** O distúrbio do sono interfere diretamente no bem-estar e na capacidade funcional do paciente.

4. Fundamento Científico e Jurídico Pesquisas recentes comprovam a eficácia do uso de CBD e THC em conjunto para o tratamento de condições como as do paciente. Estudos publicados pelo Journal of Clinical Psychiatry e pela USP confirmam que os extratos ricos nesses princípios ativos promovem alívio significativo dos sintomas de ansiedade e contribuem para a estabilização de outras condições associadas.

Conforme os artigos 6º e 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser assegurada de forma universal e integral. Também o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) exige que seja garantida a condição mínima para uma vida digna, o que inclui o tratamento necessário e eficaz.

5. Conclusão Reforço a necessidade de manutenção do tratamento com extratos de óleo de cannabis contendo 7.500 mg de CBD e 4.500 mg de THC, uma vez que as alternativas fornecidas pelo SUS são insuficientes para garantir o controle das patologias do paciente. A interrupção ou substituição do tratamento colocará o paciente em risco de agravamento de suas condições clínicas, comprometendo sua qualidade de vida e direito fundamental à saúde.

Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Anderson Batista Holzwarth - Médico
CRM: 3075 - SE

Aracaju 18/12/2024



Anderson Holzwarth

Médico

CRM: 3075